

给雨杰的说明 —— MRI查出了什么、意味着什么、接下来怎么办

（2026年8月19日更新。8月18日做了MRI，放射科报告已出。这份取代8月17日那份——那份是"我们怀疑什么"，这份是"我们现在知道了什么"。17日的推测是对的。）

一句话版本

片子找到了我们要找的东西：**你脊髓的最下端被一团很大的脂肪——脂肪瘤——"拴住"了，这团脂肪从你出生前就在那里。**就是这一件事，解释了你从小的便秘和漏尿、私处感觉减退、左腿比右腿凉和小、左脚高弓弯趾、后腰上的那块印记、还有这一年从臀部一直痛到脚跟。它有名字——**脊髓脂肪瘤引起的脊髓拴系综合征**——也有治疗方法。

报告到底说了什么，用大白话讲

- 你的脊髓终止在 **腰4（L4）** 椎体的位置。大多数人的脊髓在更高的腰1-腰2就结束了。你的位置低，是因为被拉住了。
- 拉住它的是一团 **大约12厘米长的脂肪瘤**（121 × 49 × 20 毫米），粘在脊髓末端、一直往下延伸到骶骨里面。它是脂肪——**不是肿瘤，不是癌**。医生扫描的时候给你打了造影剂，就是专门为了确认这一点，结果确认是脂肪。
- 这团脂肪长进了 **左侧腰5（L5）和骶1（S1）神经** 出来的地方，压到了这两根神经。这两根神经正好是沿着大腿后面一直到脚跟的。**这就是你的腿痛。**
- 你后腰上的那块印记**不是胎记**。它是皮肤上一条很小的"隧道"——**皮毛窦（dermal sinus）**——和脂肪瘤是同一时间形成的。它不是一直通到里面，现在还不确定（神经外科医生会查）。在弄清楚之前：**不要挤它、不要按它、不要往上面涂任何东西**；如果它发红、肿起来、流水，或者你发烧同时脖子发硬、头痛得厉害——**当天去急诊。**
- 你的椎间盘是好的。这从来就不是椎间盘的问题。
- 你去年十月做的膀胱检查（尿动力学）也对得上：膀胱容量小、过度活跃、又排不干净（残留300毫升）——这正是脊髓拴系会造成的。它不是单纯的"膀胱过度活动症"，你当时没吃那个药也没关系。

你为什么会有这个——以及它不是什么

它是在受孕后第三到第四周形成的——那时你妈妈还不知道自己怀孕了。在你后背最下面的地方，将来变成皮肤的那一层和将来变成脊髓的那一层，分开的时候没有分干净，一点跑错地方的组织变成了粘在脊髓上的脂肪。原因就是这样。**不是你做了什么，不是你爸妈做了什么，也不是怀孕时的任何事情。**全世界都有极少数孩子会这样，没有人知道为什么。它通常要到二三十岁、开始痛了才被发现——就像你一样。它和脊柱裂是一个家族的，但是闭合的、隐性的那种：你的皮肤是完整的、大脑不受影响、也不会突然恶化。

接下来怎么办

1. **看神经外科。** 关医生（Dr Guan）已经把你转给了 **Jeffrey Brennan 医生**——在 Newtown 的脊柱神经外科医生，在 RPA 医院做手术。我们现在正在约。带上：MRI报告、膀胱检查报告、你的脚和后腰印记的照片、还有 Shane 正在写的一页总结。
2. **最可能的治疗是一个把脊髓"松开"的手术**——从后腰进去，外科医生把脂肪和脊髓分开、把拴住的地方剪断，同时切掉皮肤上那条小隧道。这是很成熟的手术，是计划手术不是急诊，住院几天，恢复几个星期。
3. **手术能做到什么——说实话：**
 - **疼痛：**大多数人会明显好转。
 - **不再恶化：**这是做手术最主要的理由——腿部神经被压、最近大便习惯的变化，都是它在进展的信号。
 - **大小便、感觉：**有的人会好一些，大多数人是稳定下来，但已经异常了29年的功能往往不会完全恢复。所以盆底和肠道的治疗仍然重要——只是终于对准正确的目标了。
 - **那只脚**会保持原样。
1. **生孩子：**这**不影响**你的生育能力。到时候怀孕需要多一点安排（麻醉医生必须知道你后背的情况——没有专科医生的方案不能打普通的硬膜外麻醉；怀孕前吃高剂量叶酸；有一个膀胱管理方案）。有这个病的女性一样能顺利怀孕生下健康的宝宝。最好先做手术，再计划。

出现下面任何一条，当天去急诊

- 会阴、臀部或大腿内侧新出现的麻木
- 突然尿不出来，或者排尿突然变得很困难
- 腿或脚突然无力、或明显加重
- 大便失禁而自己完全没有感觉
- **发烧同时脖子发硬或剧烈头痛；或者后腰的印记发红、肿起来、流水**

最后

将近三十年的"我就是这样"，原来是一件事，有名字，外科医生知道怎么治。这不是你的错，也从来不是你想多了。现在它是一个计划了。